

Epistaxis masiva

1. Introducción y relevancia clínica

La **epistaxis** es el **sangrado originado en la mucosa nasal**, una de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes.

En la mayoría de los casos es leve y autolimitada, pero cuando el sangrado es **profuso o recurrente**, puede constituir una **epistaxis masiva**, con riesgo vital por **shock hipovolémico o compromiso de vía aérea**.

Epidemiología

- **Frecuencia bimodal:**
 - Niños: por traumatismos digitales o rinitis.
 - Adultos mayores: por comorbilidades (HTA, anticoagulantes, atrofia mucosa).
- En Chile, la epistaxis representa hasta el **15% de las consultas ORL en urgencia hospitalaria**.

Relevancia clínica

- Puede ser **manifestación local (trauma, sequedad, neoplasia)** o **sistémica (hipertensión, trastornos de coagulación, uso de anticoagulantes)**.
- La **epistaxis masiva** requiere manejo rápido para:
 - Controlar el sangrado.
 - Mantener la vía aérea permeable.
 - Corregir causas subyacentes.
- En el **EUNACOM**, se evalúa la **conducta inicial, manejo escalonado y criterios de derivación**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía vascular nasal

La mucosa nasal recibe irrigación de dos sistemas arteriales:

- **Sistema carotídeo externo** → arteria esfenopalatina (rama de la maxilar interna) y arteria facial.
- **Sistema carotídeo interno** → arteria etmoidal anterior y posterior (rama de la oftálmica).

Estas arterias forman dos plexos clave:

Plexo	Localización	Características
Plexo de Kiesselbach (Área de Little)	Tabique anterior	Responsable del 90% de epistaxis (anterior, leve).
Plexo de Woodruff	Pared lateral y meato inferior (posterior)	Epistaxis severa, en adultos mayores.

2.2 Mecanismos fisiopatológicos

- **Epistaxis anterior:** ruptura de capilares del plexo de Kiesselbach, de bajo flujo.
 - **Epistaxis posterior:** ruptura de ramas de la arteria esfenopalatina o etmoidal → sangrado de alto flujo y difícil control.
-

2.3 Factores desencadenantes

Locales:

- Traumatismo nasal (digital o quirúrgico).
- Rinitis aguda o crónica.
- Desviación del tabique nasal.
- Tumores nasales (angioma, carcinoma).

- Uso de sprays nasales irritantes.

Sistémicos:

- Hipertensión arterial mal controlada.
- Trastornos de coagulación (hemofilia, púrpura).
- Medicamentos: anticoagulantes, AAS, AINES.
- Alcoholismo, insuficiencia hepática.
- Fragilidad capilar en adultos mayores.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- Sangrado **unilateral o bilateral** por narina.
- Puede haber **deglución de sangre** → hematemesis o vómito hemático.
- En epistaxis posterior: sangrado por ambas narinas o por orofaringe.
- Síntomas asociados: palidez, mareo, taquicardia, hipotensión si sangrado abundante.

3.2 Clasificación clínica

Tipo	Características	Gravedad
Anterior	Sangrado visible en tabique anterior; controlable con presión o cauterio.	Leve-moderada
Posterior	Sangrado que fluye hacia orofaringe; difícil localización; requiere taponamiento o cirugía.	Grave (epistaxis masiva)

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Hemoptisis	Tos, sangre espumosa, precedida de disnea.
Hematemeis	Náuseas, sangre con restos alimentarios, melena.
Epistaxis posterior	Sangre por faringe, sin tos ni vómito previo.
Tumor nasofaríngeo	Sangrado recurrente unilateral + obstrucción nasal + otitis serosa.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial (en urgencia)

- Signos vitales: TA, FC, saturación, conciencia.
 - Evaluación del sangrado: cantidad, lateralidad, ritmo.
 - Inspección nasal con **luz frontal y aspirador**.
 - Determinar si el sangrado es anterior o posterior.
-

4.2 Exámenes de laboratorio (según gravedad)

- Hemograma (Hb, Hto).
- TP, TTPa, INR (si uso de anticoagulantes).
- Creatinina y función hepática (pacientes crónicos).

- Grupo sanguíneo y reserva cruzada si sangrado masivo.
-

4.3 Exámenes de imagen

- **No se solicitan de rutina.**
 - TAC de cavidades paranasales → si se sospecha tumor, fractura o causa estructural.
 - Angiografía → si requiere embolización arterial.
-

4.4 Criterios diagnósticos

Se diagnostica **epistaxis masiva** ante:

1. **Sangrado nasal activo persistente >15 minutos** pese a medidas iniciales.
 2. **Inestabilidad hemodinámica o Hb <10 g/dL.**
 3. Necesidad de **taponamiento posterior, cirugía o transfusión.**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Manejo inicial general (ABCDE)

- **A:** Asegurar vía aérea. Aspirar secreciones si necesario.
- **B:** Oxigenoterapia si hipoxemia.
- **C:** Monitoreo y canalización venosa. Reposición con cristaloides si hipotensión.
- Evaluar **uso de anticoagulantes** (suspender si es posible).

☐ Si el sangrado es abundante, **intubar o realizar traqueostomía** antes de la manipulación nasal.

5.2 Medidas locales iniciales (epistaxis anterior)

1. **Presión digital sobre las alas nasales** por 10–15 minutos.
 2. Aplicar **vasoconstrictor tópico** (oximetazolina o adrenalina 1:10.000 en tórula).
 3. **Compresas frías** sobre la nariz y cuello.
 4. Si se identifica punto sangrante → **cauterización química (nitrato de plata) o eléctrica**.
-

5.3 Taponamiento anterior (si sangrado persiste)

- **Material:** gasa vaselinada o taponadores nasales expansibles (Merocel®).
 - Dejar por 24–48 h.
 - Profilaxis antibiótica (amoxicilina + ácido clavulánico).
 - Retirar bajo observación médica.
-

5.4 Epistaxis posterior (masiva)

Taponamiento posterior (urgente)

- Indicaciones:
 - Sangrado persistente pese a taponamiento anterior.
 - Sangre visible en orofaringe.
- **Técnica:**
 - Colocar sonda Foley (12–14 Fr) en narina sangrante, inflar balón (5–10 mL), traccionar y fijar.
 - Asociar taponamiento anterior.
- **Monitorear:** saturación O₂ , frecuencia cardiaca, ventilación.

Si sangrado no cede → derivar a **ORL para ligadura o embolización**.

5.5 Tratamiento quirúrgico (por ORL)

Procedimiento	Indicaciones
Ligadura endoscópica de arteria esfenopalatina	Sangrado posterior refractario.
Ligadura de arteria etmoidal o carótida externa	Casos extremos.
Embolización angiográfica	Alternativa mínimamente invasiva en centros especializados.

5.6 Tratamiento de causas sistémicas

- **HTA:** control con fármacos antihipertensivos.
 - **Anticoagulados:** revertir con vitamina K o plasma fresco según INR.
 - **Trastornos de coagulación:** transfusión de plaquetas o factores.
 - **Vasculopatías / tumores:** manejo oncológico o quirúrgico.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

- **Hipovolemia o shock hemorrágico.**
- **Hipoxia / broncoaspiración** (sangre en vía aérea).
- **Sinusitis o otitis media** post taponamiento.
- **Necrosis septal** por presión prolongada.
- **Re-sangrado** tras retiro de taponamiento.

- **Muerte** (raro, en ancianos o comórbidos graves).
-

6.2 Pronóstico

- Generalmente **excelente** con tratamiento oportuno.
 - Mortalidad <1% en epistaxis masiva con manejo adecuado.
 - Mayor riesgo de recurrencia en:
 - Hipertensos mal controlados.
 - Anticoagulados.
 - Neoplasias nasales.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **mayoría de las epistaxis son anteriores y leves**, pero toda **epistaxis posterior es potencialmente grave**.
 2. **Presión nasal y vasoconstrictor tópico** son las medidas iniciales más efectivas.
 3. Si el sangrado fluye hacia la faringe, sospechar **origen posterior**.
 4. **No inclinar la cabeza hacia atrás** (favorece deglución de sangre).
 5. **Taponamiento posterior con sonda Foley** es medida de emergencia en APS.
 6. En sangrados persistentes → **ligadura de arteria esfenopalatina**.
 7. **Control de HTA y suspensión de anticoagulantes** son esenciales para evitar recidiva.
-

Errores comunes

- Dejar al paciente sin control tras taponamiento.
 - No solicitar hemograma ni coagulación en epistaxis severa.
 - Intentar cauterizar sin identificar punto sangrante.
 - No usar antibióticos tras taponamiento prolongado.
 - Omitir manejo de comorbilidades (HTA, AAS, warfarina).
 - Aspirar agresivamente, desplazando el coágulo hemostático.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **epistaxis masiva** es una urgencia potencialmente vital, más común en adultos mayores hipertensos o anticoagulados.
2. **La mayoría de los casos son anteriores y autolimitados**, pero las **posteriores requieren manejo avanzado**.
3. **Medidas iniciales:** presión nasal, vasoconstrictor tópico y posición sentada.
4. Si persiste → **taponamiento anterior**, y si continúa → **taponamiento posterior con sonda Foley**.
5. **Tratamiento definitivo:** ligadura endoscópica o embolización.
6. Siempre **controlar comorbilidades sistémicas** (HTA, anticoagulantes).
7. Pronóstico excelente si manejo precoz y adecuado.